EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	87629
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2024-07-01 10:02:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUANA ALIDA MU►OZ LAGOS			RUN	: 7.643.562-6
F.Nac	: 02-09-2023	Edad	: 0 AÑO, 9 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-06-07	Fecha Egreso	: 2024-07-01 10:02:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I21-INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Post operatorio (27/05/24):
- CRM: CRM LIMA DA + PAC CD por ES2V
- RVMi con prótesis biológica por Insuficiencia mitral severa
2. IAM SEST Killip 1 reciente (16.05.24)
3. Cardiopatía coronaria (PTCA STENT previas ACDp y ACDm en 2017)/FEVI 40%(preqx)
4. LRA KDIGO 2 sobre ERC etapa 3b
6. Delirium mixto resuelto
6. Antecedentes crónicos: HTA, DM2, EPOC tabáquico

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I34.0-INSUFICIENCIA (DE LA VALVULA) MITRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I50.9-INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I48.0-FIBRILACION AURICULAR PAROXISTICA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. J90.X-DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. E10-DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. D50-D53-ANEMIAS NUTRICIONALES (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. N17-INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente ingresa a UTI trasladada desde HLHT, donde estuvo hospitalizada del 27/05 al 02/06 tras ser derivada desde HSC para CRM + RVMi. La paciente presentó un IAM SSDST el 15/05 en ese contexto se realizó estudio coronario el 16/05, que mostró ES2V y ECOcardio: Insuf. mitral severa. Ingresa a pabellón el 27/05, realizándose Reemplazo válvula mitral con prótesis biológica y CRM LIMA DA + PAC CD, sin incidentes intraoperatorio. Se extuba el mismo día de la cirugía, salida a naricera con FiO2 la cual se mantiene ya que desatura sin este. Evoluciona con cuadro de vasoplejia en primeras 48h de postoperatorio junto con un episodio de mioclonías aisladas autolimitadas. Se suspende NAD el 29/05. Presenta delirium hiperactivo manejado con antipsicóticos (precedex y posteriormente quetiapina) con buena respuesta. Deambulación tardía y aun consolidando destete de O2 por episodios de broncoespasmo leve. A lo anterior se asocia adicionalmente LRA sobre crónica pero en regresión, con diuresis conservada con requerimiento de diuréticos. Ha necesitado refuerzo con IR pre-comidas por hiperglicemia. No se describen conflictos infecciosos durante su estadía en UCO. Llega a UTI en buen estado general, vigil y orientada, con apoyo FiO2 2 lt por naricera. Con accesos de tos seca, lo cual genera dolor esternal. Sin signología obstructiva respiratoria, sin signología congestiva. En lo infecioso con URO (+) Citrobacter freundi (S) Ceftriaxona.Evoluciona con requerimientos progresivos de O2 extra. Se confirma derrame pleural bilateral mayor a derecha progresivo. Hoy 0.9.06.24 con mayor deterioro a derecha pulmonar con más necesidad de O2 extra en nCNAF 65% Gsa con PaFi: 113. Poer ello se traslada a UCI, se procede a IOT con SIR (fenta/mida/rocu) sin incidente. Instalación de CVC. RxTx control ambos procedimientos sin conflictos.
Grave Inestable Pa 126/36 Mmhg Pam 61 Fc 92 Fr 16 Tp 37.6 Fio2 35% Sato2 93 Diuresis 171 Ml/24h Bha(+)945 Bha (+)3200 Hgt 161 Hgt Promedio 152 Fentanilo 2.4 Mcg/Kg/H Midazolam 0.03 Mg/Kg/H Nad 0.12 Mcg/Kg/Min Dbt 2.5 Mcg/Kg/Min, Con Requerimientos De Dva En Ascenso, Se Le Inicia Apoyo Con Inótropos, Ritmo De Fa Aparentementa Aguda, Bh (+), Lactato 0.7, Respiratorio: Ascenso De Pafi A 254, Se Disminuye Fio2 A 35% De 60% Previo, Febril Desde Ayer , No Tiene Cultivos Tomados , Elevación Pcr , Ascenso De Parámetros Inflamatorios, Le Escalaron Atb Ayer, Oligoanuria, Acidosis Metabólica, Hiperkalemia, Buen Control Glicémico.
Para El 10.6 .24 Se Omite Nad, Se Avanza Dbt Hasta 5 Mcg/Kg/Min , Se Adiciona Amiodarona Por Fa Aguda Y Indica Anticoagulacion, Bh (+), Ademas Recibe Furosemida En Bic 0.05 Mg/Kg/H. Disminuye Pafi A 183, Fio2 A 35% De Manera Constante, Fr 14-16 Rpm, Se Superficializa Sedación, Se Retira 2 Cm Tot Por Encontrarse En La Carina Hoy Febril Durante La Mañana, Luego Subfebril, Se Pancultiva, Se Mantiene Atb, Se Solicta Panel Viral Respiratorio. Diuresis Arrastrada Pero Mejora, Se Corrige Acidosis Metabólica, Mejora Levemente Hiperkalemia De 5.60 A 5.30 , Regular Control Glicémico.
11.6.24 mejor perfundida, Láctico: 0.7, con VEC conservado. Conectado a VMI modo CPAP con PEEP: 8, Fio2: 35%, buena mecánica ventilatoria, bien acoplada, Pafi; 233 se realiza PVE con buenos índice de TOBIN por lo que se decide extubación, sin embargo sale desaturando, se define conectar a VMNI, a la auscultación MV abolido en 1/3 medio y base de pulmón derecho por lo que se solicita evaluación por cirujano para eventual drenaje e instalación de tubo torácico. Subfebril, PCR a la baja 183(213), persiste con leucocitosis, PCT 0.42, recibe ATB de amplio espectro en espera de resultados de cultivos. Con mejoría del volumen urinario, ayer recibió BIC de furosemida, función renal alterada sin cambios respecto al día anterior, Crea: 2.2, mejoría de la hiperkalemia, hoy K+: 5.0, metabólicamente estable, tolerando regimen enteral, hoy muy nauseosa. Cirugia Paciente 2° dia en UCI postoperado CRM. Extubada hoy, se solicita evaluacion por derrame pleural masivo derecho evidenciado en TAC con

apremio ventilatorio y desaturaciones. Bajo tecnica aseptica y previa anestesia local, se instala SEP en 5° EIC derecho a nivel de LAM que se fija a 8 cm con doble seda y da salida a liquido pleural citrino. Se toman 50 cc para cultivo. Se extraen 1000 cc y se clampea por tos. Inmediatamente mejora saturacion de 86% a 95%. Se conecta a trampa de agua y se deja a caida libre por hoy.
1° Dia Sep Paciente En Mejores Con Fa Refractaria A Tto, Hipertensa, Sat 84 - 86% Con O2 Por Nrc Fio2 32%. Ayer Por La Noche Se Desconecta De Vni Y Se Deja Soporte O2 Por Naricera Se Suspendio Bic De Heparina Sep Derecho 1900 Cc (Desde Instalacion) Serohematico Claro, Oscila No Fuga . Rx Evidencia Gran Reexpansion Pulmonar Derecha.

13.6.24: 48 hrs extubada, bajo apoyo de VMNI I/E 18/8 Fr 16 FiO2 32% → 24%, con deterioro gasométrico en la mañana con respecto a previo pero conserva buena mecánica ventilatoria, control de la tarde con PaFI 306. tolerando ventanas de alimentación con NRC. SEP pleural oscilante con RX con re expansión casi total del pulmón derecho, ayer con bajo gasto <100cc/24 hrs, pero que al bipedestar el día de hoy elimina 500cc. Afebril, Parámetros inflamatorios en franco descenso PCR 79.5 (198), PCT 0.20 (0.42), por sospecha de NAAS se habría escalado Atbo a 3ra línea con meropenem + vancomicina, sin embargo CAT (-) UC (-), HCs negativos a la fecha.Diuresis conservada, bajo terapia depletiva con función renal en recuperación Creat 1.3 (2.0), sin DHE. Mejor control metabólico.Tolera alimentación oral, evaluada por FA se le retiro SNG ayer. Bajo BIC de analgesia, no refiere dolor por lo que suspendo.

17. 6. 24 Sin Dva, Hta, Se Adiciona Entresto Y Se Aumenta Dosis De Furosemida , Bha Negativo, Ritmo Sinusal Fc 74-78 Lpm, Bien Perfundida, Nt-Probnp >25.000, Se Solicita Ecocardiograma, Se Adiciona Empaglifozina . En Ventana Sin Vmni, Fio2 Constante 36%, Fr 22-24 Rpm, No Mala Mecánica , Se Realiza Toracocentesis Diagnostica Se Extraen 60 Ml Liquido Cetrino, Según Gradiente Alb Serico/Alb Lp Es Trasudado, Disminuye Pafi 163. Afebril , Parámetros Inflamatorios En Descenso, Pcr 54,10 (Previo 63,3). Diuresis Adecuada, Hiponatremia Leve Probablemente Dilucional Leve Ascenso Na 133, Mejor Control Glicemico, Sin Embargo Se Disminuye Insulinoterapia, Tolera Regimen , No Acidosis Metabólica

25.6.24 Ventilando espontaneo, sin requerimientos de O2, sin UMA, buen intercambio Pafi: 337, aun con Pigtail pleural derecho, ayer gasto escaso 40 cc, citrino. Hemodinamia estable, bien perfundida, sin DVA, VEC conservado. Subfebril, parámetros inflamatorios al alza, PCR: 218, PCT: 0.23, leucocitosis de 14.000, con ATB de amplio espectro. Diuresis aceptable, BHA negativo, con hiponatremia leve de 134, función renal estable, Crea: 1.5. Regular control metabólico, tolerando alimentación oral. Con deposiciones abundantes ayer. Se levanta y deambula asistido con Kine.
01.7.24 Paciente BCG, Ventilando espontaneo, sin requerimientos de O2, sin UMA, buen intercambio.Se retiro Pigtail pleural derecho, (26/06 POR BAJO DEBITO).Hemodinamia estable, bien perfundida. Afebril, con ATB de amplio espectro. Mejor control metabólico, tolerando alimentación oral. Se levanta y deambula asistido con Kine.Deposiciones - . Diuresis: + | BH: no registrado . función renal estable, Crea: 1,40 * mg/dl Clearence Calculado(MDRD) : 37,39 Proteina C Reactiva : 30,9 en condiciones de Alta por HODOM.

PLAN DE MANEJO:

alta con hodom
completar tto atb
control de función renal diario
continuar con tto crónico
control sos

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Relativo Asistido
2. Regimen Liviano Hiposodico Diabetico, Restriccion Hidrica 800ml/H
3. Kine Motora y respiratoria
4. Brexotide 250/25 2 Puff C/12h Inh
5. Br Ipratropio 2 Puff C/8 Hrs Inh
6. Ins Nph 6 U Am - 6 U Pm Sc
7. Metolazona Comprimido 2,5 Miligramos 1 Comprimido Cada 12 Hrs. Por 30 Dias Via Oral
8. Ceftazidima Frasco Ampolla 1 Gramo 2 Frasco Ampolla Cada 12 Hrs. Por 3 Dias Via Endovenosa
9. Vancomicina Ampolla 500 Milígramos 2 Ampolla Cada 24 Hrs. Por 3 Dias Via Endovenosa
10. Omeprazol Comprimido 20 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 15 Dias Via Oral
11. Bisoprolol Comprimido 2,5 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 30 Dias Via Oral
12. Empagliflozina 10mg Comprimido Unidad 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 30 Dias Via Oral
13. Atorvastatina Comprimido 40 Miligramos 2 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 30 Dias Via Oral
14. Acido Acetilsalicilico Comprimido 100 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 30 Dias Via Oral
15. Apixaban Comprimido 2,5 Miligramos / Minilitros 1 Comprimido Cada 12 Hrs. Por 30 Dias Via Oral
16. Espironolactona Comprimido 25 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 30 Dias Via Oral
17. Amiodarona Comprimido 200 Miligramos 1 Comprimido Cada 12 Hrs. Por 30 Dias Via Oral
18. Lactulosa Solución 65% Frasco 200 Minilitros 20 Ml Cada 8 Hrs. Por 15 Dias Via Oral, 20ml C/8hrs

EXÁMENES Y RESULTADOS

EKG 29/05/2024 RS/81/0.08/0.28/0.08/+30°/0.32 VM TS BIRIHH, BAV IG, LESION SUBEPICARDICA CARA INFERIOR.
LAB 10/06/2024 LEUC: 17,500 HTO : 28 HB: 8,8 V.C.M. : 92,7 C.H.C.M. : 31,6 PLAQUETAS : 354 VHS 34 INR : 1,06 TP 91 CREAT 2,20 CA 7,9 FA 197 BI 0,13 BD 0,27 BT 0,40 GOT 25 GPT 17 GGT 130 MDRD 22,20 LACTATO 0,7 PCR 213,7 BUN: 40 UREMIA : 85 NA 139 K 5,60 CL 107 PH : 7,28 PCO2 : 42,5 PO2 : 89,2 HCO3 20,1 BE (B) : -5,3 O2 SAT : 96 PAFI 254 BA 11,9
TAC TÓRAX 07/06/2024 Moderado Derrame Pleural Derecho. Atelectasia Del Lóbulo Inferior Derecho Tenues Opacidades Aisladas En Vidrio Esmerilado En Campo Pulmonar Derecho Leve Derrame Pleural Izquierdo. Atelectasia Subsegmentaria Basal Izquierda Cardiomegalia. Leve Derrame Pericárdico.
Coronariografía 16/05/24: Tronco coronario izquierdo Sin lesiones obstructivas Arteria descendente anterior Descendente anterior medio con estenosis severa (90%) de 15 mm de largo. Arteria circunfleja Sin lesiones obstructivas Arteria coronaria derecha Coronaria derecha proximal con estenosis oclusiva(100%) de 30 mm de largo. Stent visible en coronaria derecha proximal con reestenosis severa (100%) oclusiva. Coronaria derecha mediacon estenosis oclusiva (100%) de 30 mm de largo. Stent visible en

coronaria derecha media con reestenosis severa (100%) oclusiva.
ECOCARDIOGRAMA 17/05/2024 FEVI 40%. Vi Con Hipocinesia De Segmentos Medios Y Basal De Pared Inferior , Inferoseptal, Inferolateral. Ai Severamente Dilatada Valvula Mitral Con Insuficiencia Severa.
25/06/24 Creat 1.5 Na+ 134 K+ 4.8 PCR: 218 Alb: 2.7 Lactato: 0.8 PCT: 0.23 PH: 7.52 Pco2: 33 Po2: 70.8 Hco3: 27 Sto2: 94% PaFI 337.
11/06/2024 Cultivo Líquido Pleural (-)
HC 1-2-CVC 10/06/2024: Negativo - CAT: Negativo - UC: Candida Glabrata

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO